



EVALUATION SUJET : 59

POLYTRAUMATISME

Dr KHARRAT Sana

Pr CHTARA Kamilia

CHU Habib Bourguiba ,réanimation médicale, Sfax

Concernant le polytraumatisé

- A. C'est un patient qui présente deux lésions ou plus, dont une au moins menace le pronostic vital.
- B. C'est un patient dont le mécanisme du traumatisme prédit la présence de lésion qui menace le pronostic vital.
- C. c'est un patient qui présente des lésions dont l'évolution est indépendantes les unes des autres.
- D. La présence d'un décédé dans le même véhicule, témoigne de la gravité du mécanisme.
- E. Les traumatismes indirects (décélération, effet blast) sont obligatoirement responsables de lésions pariétales

Les critères de gravité pour le triage des patients traumatisés.

- A. Âge > 45 ans**
- B. Une chute de deux mètres**
- C. Éjection d'un véhicule**
- D. Pression artérielle systolique < 90 mmHg**
- E. Saturation en O₂ < 90 %**

Critères de Vittel : critères de gravité pour le triage des patients traumatisés.

Cinq étapes d'évaluation	Critères de gravité
Variables physiologiques	• Score de Glasgow < 13 • Pression artérielle systolique < 90 mmHg • Saturation en O₂ < 90 %
Éléments de cinétique	• Éjection d'un véhicule • Autre passager décédé dans le même véhicule • Chute > 6 m • Victime projetée ou écrasée • Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, absence de casque, absence de ceinture de sécurité) • Blast
Lésions anatomiques	• l'abdomen, du bassin, du bras ou de la cuisse • Volet thoracique • Brûlure sévère, inhalation de fumées associée • Fracas du bassin • Suspicion d'atteinte médullaire • Amputation au niveau du poignet, de la cheville, ou au-dessus • Ischémie aiguë de membre
Réanimation pré hospitalière	• Ventilation assistée • Remplissage > 1 000 ml de colloïdes • Catécholamines • Pantalon antichoc gonflé
Terrain (à évaluer)	• Âge > 65 ans • Insuffisance cardiaque ou coronarienne • Insuffisance respiratoire • Grossesse (deuxième et troisième trimestres) • Trouble de la crase sanguine

Concernant la prise en charge d'un polytraumatisé en pré hospitalier

- A. La stabilisation du rachis cervical est une priorité
- B. Un traumatisé crânien grave est considéré comme blessé médullaire jusqu'à preuve du contraire
- C. L'objectif du remplissage en préhospitalier est de ramener la PA systolique aux alentours de 110 mm Hg en absence de traumatisme crânien.
- D. L'intubation et l'assistance ventilatoire ne peuvent pas être envisagés en pré hospitalier.
- E. L'immobilisation des fractures est réalisée dès le ramassage.

Concernant la détresse neurologique

- A. L'état de coma chez un polytraumatisé est toujours en rapport avec traumatisme crânien.
- B. L'absence de signes de localisations chez un patient comateux élimine la présence des lésions du rachis cervicales.
- C. Les agressions qu'il faut éviter sont essentiellement l'hypotension artérielle et l'hypoxémie
- D. L'osmothérapie par mannitol ou sérum salé hypertonique en cas d' HTIC n'est pas envisagé en préhospitalier.
- E. Le contrôle des ACSOS doit être envisagé dès la phase préhospitalière des traumatisés crâniens sévères

Concernant l'état de choc chez un polytraumatisé

- A. Le choc cardiogénique est la forme la plus fréquente.
- B. La présence de turgescence des veines jugulaire est en faveur de l'origine hypovolémique du choc.
- C. L'état de choc peut être secondaire à un traumatisme médullaire.
- D. L'état de choc peut être secondaire à augmentation de la pression intrathoracique.
- E. Les fractures de membres peuvent être responsables d'un état de choc hémorragique.

Au cours de la phase d'accueil d'un polytraumatisé : les objectifs à atteindre

- A. Une diurèse > 1ml/kg/h.**
- B. Une température centrale entre 36 et 37°C.**
- C. Une SpO₂ > 92 %**
- D. Une PAM proche de 60 - 70 mmHg, si l'hémorragie est contrôlée.**
- E. Une PAM à 80-90 mmHg, si traumatisé crânien et/ou médullaire grave.**

Concernant la prise en charge d'un polytraumatisé à l'hôpital.

- A. Il faut surveiller la température et lutter contre l'hypothermie**
- B. L'analgésie du patient doit être envisagée**
- C. La voie sous Clavière doit être privilégiée en cas de nécessité d'une voie centrale**
- D. IL faut mettre en place une sonde naso-gastrique en cas de traumatisme crânien avec coma.**
- E. L'administration d'une antibioprophylaxie est obligatoire**

Concernent la prise en charge opératoire:

- A. Il n'y a pas de stratégie standard qui est applicable à tous les polytraumatisés.
- B. La détresse respiratoire prime sur la détresse circulatoire
- C. La détresse neurologique prime sur la détresse respiratoire
- D. La détresse neurologique prime sur la détresse circulatoire.
- E. La lésion qui engage le pronostic vital prime sur celle qui engage le pronostic fonctionnel

Les traumatismes directs :

- A. Peuvent entraîner une atteinte des organes à distance
- B. Peuvent entraîner une atteinte des organes sous-jacents
- C. Peuvent être secondaires à des agents tranchants
- D. Peuvent être secondaires à une décélération
- E. Sont responsables de lésions pariétales

Les traumatismes indirects peuvent être secondaires à :

- A. Un agent contondant**
- B. Un agent pénétrant**
- C. Une décélération**
- D. Une hyperflexion-extension brutale du rachis cervical**
- E. Une onde de choc de l'effet de souffle**

Parmi les critères de gravité d'un polytraumatisé, on cite

- A. Un volet thoracique**
- B. Un fracas du bassin**
- C. Un score de Glasgow entre 13-15**
- D. Une pression artérielle systolique < 90 mmHg**
- E. Une saturation en O₂ à 93 %**

Le mécanisme d'un traumatisme est considéré grave si :

- A. Le choc est violent avec une déformation du véhicule**
- B. La victime a chuté d'une hauteur de 1m**
- C. La victime est écrasée**
- D. La victime est éjectée du véhicule**
- E. Un autre passager est décédé dans le même véhicule**

La détresse respiratoire chez un polytraumatisé est secondaire à :

- A. Un traumatisme crânien grave**
- B. Un traumatisme périphérique**
- C. Un traumatisme maxillo-facial**
- D. Un traumatisme thoracique**
- E. Une lésion médullaire au dessous de C6**

La détresse circulatoire lors d'un polytraumatisme est secondaire à :

- A. Une contusion myocardique
- B. Un pneumothorax compressif
- C. Un traumatisme médullaire au dessous de T6
- D. Une brûlure étendue
- E. Une tamponnade

L'objectif de la prise en charge préhospitalière est

- A. Faire un bilan lésionnel complet**
- B. Chercher et traiter les détresses vitales**
- C. Assurer le ramassage sans aggraver les lésions préexistantes**
- D. Prévenir l'hypothermie**
- E. Assurer le transport au centre hospitalier le plus approprié**

Un traumatisme thoracique est évoqué devant

- A. La présence des signes de lutte**
- B. La présence d'une respiration paradoxale**
- C. La présence d'une ecchymose thoracique**
- D. L'existence d'une cyanose**
- E. Une polypnée avec respiration ample**

Les indications d'une intubation endotrachéale et ventilation mécanique chez un polytraumatisé sont :

- A. L'association d'un traumatisme thoracique et abdominale**
- B. Le besoin d'une sédation-analgésie**
- C. Une détresse circulatoire malgré une réanimation adéquate**
- D. Une détresse neurologique avec score de Glasgow à 13**
- E. Une détresse respiratoire non améliorée par une oxygénothérapie**

Le diagnostic d'un état de choc hémorragique est évoqué devant l'association des signes suivants :

- A. L'existence d'un point d'impact abdominal**
- B. L'existence d'une cyanose**
- C. Une hypotension avec une différentielle pincée**
- D. Une turgescence des veines jugulaires**
- E. Une tachycardie**

Un état de choc obstructif secondaire à un pneumothorax compressif est évoqué devant l'association des signes suivants :

- A. Des râles sibilants à l'auscultation pulmonaire
- B. Un emphysème sous cutané
- C. Une pâleur cutanéomuqueuse
- D. Une suffocation chez le blessé conscient
- E. Une turgescence des veines jugulaires

Un état de choc obstructif secondaire à une tamponnade est évoqué devant l'association des signes suivants

- A. Un emphysème sous cutané
- B. Une abolition des murmures vésiculaires à l'auscultation
- C. Une diminution des bruits du cœur à l'auscultation
- D. Une suffocation chez le blessé conscient
- E. Une turgescence des veines jugulaires

La pression artérielle moyenne (PAM) chez le polytraumatisé avec une hémorragie non contrôlée doit être :

- A. Entre 50-60mmHg
- B. Entre 60- 70 mmHg
- C. Entre 70-80 mmHg
- D. Entre 75-85mmHg
- E. Entre 90-100 mmHg

La pression artérielle moyenne (PAM) chez le polytraumatisé avec une hémorragie contrôlée doit être :

- A. Entre 50-60mmHg
- B. Entre 60- 70 mmHg
- C. Entre 70-80 mmHg
- D. Entre 75-85mmHg
- E. Entre 90-100 mmHg

Le taux de plaquettes chez un polytraumatisé avec un traumatisme crânien grave associé doit être :

- A. Supérieure à 50000/mm³
- B. Supérieure à 75000/mm³
- C. Supérieure à 100000/mm³
- D. Supérieure à 120000/mm³
- E. Supérieure à 150000/mm³

Le taux de prothrombine chez le polytraumatisé doit être :

- A. Supérieure à 40%
- B. Supérieure à 50%
- C. Supérieure à 60%
- D. Supérieure à 70%
- E. Supérieure à 80%

En arrivant à la salle de déchoquage, le polytraumatisé doit bénéficier sur le brancard et en urgence des examens paracliniques suivants :

- A. Abdomen sans préparation
- B. Echographie abdominale
- C. Radiographie du bassin
- D. Radiographie du rachis cervical
- E. Radiographie de thorax

À combien évaluer vous le volume du saignement en cas de fracture tibiale?

- A. 500 ml
- B. 1000 ml
- C. 2000 ml
- D. 3000 ml
- E. 5000 ml

À combien évaluer vous le volume du saignement en cas de fracture du fémur?

- A. 500 ml
- B. 1000 ml
- C. 2000 ml
- D. 3000 ml
- E. 5000 ml

Quelle est la principale étiologie de l'EDC post traumatique

- A. Hypovolémique par hémorragie
- B. Obstructif par pneumothorax
- C. Obstructif par hémothorax
- D. Septique par translocation digestive
- E. Cardiogénique par contusion myocardique

Quelle lésion doit elle être systématiquement évoquée devant tout traumatisme crânien?

- A. Traumatisme médullaire cervical**
- B. Traumatisme médullaire thoracique**
- C. Traumatisme médullaire lombaire**
- D. Syndrome de la queue de cheval**
- E. Traumatisme costal**

Quelles sont les causes d'éventuels troubles de l'hémostase

- A. Déshydratation extra cellulaire**
- B. Hypothermie**
- C. Hypocalcémie**
- D. Transfusion de Culots globulaire à répétition**
- E. Acidose**

Un traumatisme de l'hypochondre gauche peut causer une lésion:

- A. de la rate**
- B. du pancreas caudal**
- C. de la coupole diaphragmatique ipsilatérale**
- D. de l'angle colique gauche**
- E. du confluent bilio-pancréatique**

Un traumatisme de la région ombilicale doit faire suspecter une lésion:

- A. du pancréas**
- B. du grêle**
- C. des gros vaisseaux**
- D. du cadre colique**
- E. de la vessie**

Au cours de l'évaluation de la gravité d'un polytraumatisme :

- A. Les traumatismes des membres ne modifient pas le pronostic du patient
- B. Le mécanisme de l'accident est un critère d'évaluation de la gravité
- C. Un âge jeune constitue un critère de gravité majeur
- D. La prise d'un médicament modifiant la crase sanguine est à considérer
- E. Elle doit se faire dès la prise en charge préhospitalière

Concernant la prise en charge d'un polytraumatisme en préhospitalier

- A. Elle doit commencer sur les lieux de l'accident
- B. L'intubation orotrachéale est indiquée si le score de Glasgow est inférieur à 9
- C. L'exsufflation d'un pneumothorax compressif ne peut pas être réalisée en absence de preuve radiologique
- D. Un remplissage vasculaire par 30ml/Kg de cristalloïdes doit être réalisé
- E. L'injection d'acide tranexamique est recommandée en cas d'état de choc hémorragique

Lors de la défaillance circulatoire post traumatique :

- A. La cause hémorragique est la plus fréquente
- B. La nature vasoplégique est évoquée quand la PAD est maintenue
- C. Le choc obstructif est suspecté en cas de turgescence des jugulaire et emphysème sous cutané
- D. Le choc obstructif est évoqué devant la turgescence des jugulaire et diminution des bruits du cœur
- E. Le choc cardiogénique est évoqué en présence de turgescence des jugulaires avec des râles crépitants

Concernant la prise en charge chirurgicale initiale d'un polytraumatisé :

- A. La présence d'un état de choc hémorragique non contrôlé indique une intervention chirurgicale urgente
- B. La prise en charge chirurgicale des lésions neurologiques doit être réalisée en premier lieu
- C. Aucun geste opératoire ne doit être réalisé si le taux d'Hb est inférieur à 10 g/dl
- D. Une thoracotomie d'hémostase ne peut pas être faite avant la réalisation d'un scanner thoracique
- E. Une laparotomie médiane peut être indiquée suite à la présence d'un épanchement à l'échographie au lit du malade

Concernant les mécanismes du polytraumatisme :

- A. Le blast provoque surtout des arrachements de pédicules vasculaires (foie, rate, aorte)
- B. L'hyperflexion-extension cervicale peut être responsable de fractures des vertébrales
- C. La décélération entraîne contusions, ruptures d'organes pleins et arrachements vasculaires
- D. Le syndrome d'écrasement expose surtout à une hypokaliémie avec myoglobinurie
- E. Le pronostic vital n'est pas engagé tant que toutes les lésions ne sont pas graves isolément

Concernant les associations lésionnelles :

- A. Le phénomène de sommation rend vitales plusieurs lésions mineures
- B. Le phénomène d'occultation signifie une lésion masque une autre
- C. L'association d'une insuffisance respiratoire et d'un coma illustre un phénomène d'aggravation
- D. Le coma permet d'écarter une atteinte du rachis
- E. Deux fractures isolées n'ont jamais d'impact pronostique

Dans la prise en charge préhospitalière du polytraumatisé, l'objectif tensionnel est :

- A. PAS $\approx$ 80 mmHg quel que soit le contexte**
- B. PAM $\approx$ 60 mmHg chez tout patient**
- C. PAS $\geq$ 110–120 mmHg en cas de traumatisme crânien associé**
- D. PAS 90 mmHg en cas de suspicion de lésion médullaire**
- E. PAS 100 mmHg chez tout patient âgé**

Les critères de Vittel incluent :

- A. GCS = 14, chute < 3 m, éjection d'un véhicule
- B. GCS < 13, chute > 6 m, éjection d'un véhicule
- C. PAS 95 mmHg, blast, suspicion de contusion pulmonaire
- D. GCS 12, PAS 100 mmHg, âge > 70 ans
- E. GCS < 9, PAS 85 mmHg, perte de connaissance initiale

Parmi les causes de détresse circulatoire chez le polytraumatisé, la plus fréquente est :

- A. Hypovolémie hémorragique**
- B. Choc obstructif (tamponnade, pneumothorax compressif)**
- C. Choc cardiogénique post-contusion myocardique**
- D. Choc vasoplégique (lésion médullaire haute)**
- E. Hypovolémie par brûlures étendues**

Le syndrome d'écrasement :

- A. Se complique typiquement d'une hypocalcémie
- B. Se complique typiquement d'une Hyperkaliémie
- C. Il est prévenu par remplissage et alcalinisation des urine
- D. Il peut évoluer vers une insuffisance rénale aiguë
- E. Il ne survient que dans les traumatismes directs

Dans la prise en charge d'un polytraumatisé :

- A. La détresse ventilatoire est prioritaire sur la circulatoire
- B. La détresse circulatoire est prioritaire sur la neurologique
- C. La neurologique prime toujours sur la détresse ventilatoire
- D. Les trois détresses sont équivalentes
- E. La priorité dépend uniquement du mécanisme

La « triade létale » du polytraumatisé associe :

A. Hypothermie

B. Acidose métabolique

C. Coagulopathie

D. Hyperkaliémie

E. Hypocalcémie

Le bilan radiologique initial urgent comporte :

- A. Radiographie thorax
- B. Radiographie bassin
- C. Échographie abdominale (FAST)
- D. Scanner corps entier immédiat
- E. Scanner cérébral systématique

Chez le polytraumatisé, les causes de détresse respiratoire sont:

- A. Contusion pulmonaire**
- B. Pneumothorax compressif**
- C. Volet thoracique**
- D. Traumatisme du rachis dorsal**
- E. Obstruction VAS**

La stratégie de « damage control resuscitation » associe :

- A. Ratio transfusionnel GR/PFC/Plaq $\approx$ 1:1:1
- B. Correction précoce de l'hypocalcémie induite par les transfusions
- C. Administration systématique de mannitol
- D. Hypothermie thérapeutique
- E. Limitation des apports de cristaalloïdes

Devant un traumatisé inconscient (GCS 6) trouvé sur la voie publique :

- A. L'intubation orotrachéale n'est indiquée que si un état de choc est associé**
- B. L'intubation orotrachéale est indiquée systématiquement**
- C. La mise en place d'une canule de Guedel suffit si ventilation spontanée**
- D. On privilégie la ventilation non invasive en première intention**
- E. L'intubation est contre-indiquée si suspicion de lésion cervicale**

Dans le bilan lésionnel initial, l'échographie FAST sert surtout à :

- A. Diagnostiquer une fracture costale**
- B. Détecter un épanchement intra-abdominal ou thoracique**
- C. Évaluer la volémie centrale**
- D. Mesurer la pression artérielle pulmonaire**
- E. Rechercher une lésion d'un organe creux**

En cas de suspicion de lésion de l'aorte post traumatique :

- A. L'échographie transthoracique suffit**
- B. L'angio-scanner thoracique est l'examen de choix**
- C. La radiographie thoracique peut montrer un élargissement du médiastin**
- D. L'IRM thoracique est obligatoire**
- E. On attend la stabilisation complète pour tout examen**

La douleur du polytraumatisé :

- A. Est traitée uniquement après stabilisation hémodynamique
- B. Peut aggraver l'hypoxémie et l'état circulatoire
- C. Peut entraîner une agitation entravant la prise en charge
- D. Doit être systématiquement soulagée dès la prise en charge initiale
- E. Les opioïdes ne peuvent pas être commencés en préhospitalier

cas clinique 1:

Homme de 28 ans, motard, conduit à 120 km/h heurté par une voiture.

Arrivée du SMUR :

GCS = 7/15 , anisocorie droite.

TA = 80/40 mmHg, FC = 140/min.

SpO₂ = 85 % sous masque O₂.

Thorax gauche : tympanique, abolition des MV.

eFAST : liquide libre abdominal.

QCM 1 — Priorités de prise en charge préhospitalière

- A. Intubation oro-trachéale avec protection de l'axe cervical
- B. Perfusion de 3 L de NaCl 0,9 % rapide
- C. Décompression thoracique gauche d'urgence
- D. Transport immédiat au scanner corps entier
- E. Mise en place d'un collier cervical rigide

QCM2 : Les causes possibles de l'état de choc sont:

- A. Hémorragie intra-abdominale
- B. Pneumothorax compressif
- C. Tamponnade traumatique
- D. Contusion myocardique
- E. Hémorragie intracérébrale isolée

QCM 3 — La Stratégie thérapeutique en urgence hospitalière comporte

- A. Drainage thoracique gauche
- B. Laparotomie d'hémostase (damage control)
- C. Scanner corps entier avant le bloc
- D. Maintien d'une PAS ≥ 110 mmHg (TC associé)
- E. Transfusion de CG avec un objectif Hb >7 g/dl

Cas clinique 2 :

Homme de 35 ans retrouvé sous des gravats après effondrement d'un immeuble, coincé par Ses membres inférieurs pendant 6 heures.

TA = 95/60 mmHg, FC = 120/min.

Douleur intense des jambes, œdème, crépitation musculaire.

QCM1: Les risques immédiats à la levée de la charge sont:

- A. Hyperkaliémie avec troubles du rythme**
- B. Hypocalcémie sévère**
- C. hypotension artérielle**
- D. Acidose métabolique**
- E. Coagulopathie de consommation**

QCM2 : Les complications secondaires sont:

A. Insuffisance rénale aiguë par myoglobininurie

B. Hypocalcémie transitoire

C. Syndrome de loge

D. Insuffisance respiratoire aiguë

E. Coagulopathie

QCM 3 — Mesures thérapeutiques initiales

- A. Remplissage intraveineux précoce et abondant
- B. Alcalinisation des urines
- C. Administration systématique de mannitol
- D. Surveillance électrocardiographique continue
- E. Décompression chirurgicale si syndrome compartimental

Cas clinique 3 :

Homme de 40 ans, accident de la voie publique, choc latéro-thoracique droit.

À l'arrivée au SAUV : PA = 85/50, FC = 130, SpO₂ = 88 %.

À l'examen : Pâleur cutanéomuqueuse, polypnée, thorax droit creux et douloureux, crépitants sous-cutanés.

Radiographie thorax : élargissement du médiastin, hémopneumothorax droit, fractures étagées.

QCM 1 — Les lésions post-traumatiques suspectées

- A. Contusion pulmonaire sévère
- B. Rupture de l'aorte thoracique
- C. Volet costal
- D. Rupture diaphragmatique
- E. Contusion myocardique

QCM 2 — Examens complémentaires à demander sont:

- A. Scanner thoracique avec injection (si état stabilisé)
- B. Radiographie thorax de profil
- C. Échographie pulmonaire
- D. Angio-IRM thoracique en urgence
- E. ECG + troponines

QCM :La prise en charge hospitalière comporte

- A. Mise en place d'un drain thoracique droit
- B. Oxygénothérapie avec objectif de SpO2 92 %
- C. Laparotomie exploratrice immédiate
- D. Transfusion sanguine avec un objectif de Hb à 10 g/dl
- E. La pose d'un cathéter veineux central en sous clavier

Cas Clinique 4

Homme de 50 ans, chute de 5 m.

Constantes : PA = 100/60, FC = 90, SpO₂ = 96 %.

GCS = 15/15, mais paraplégie flasque avec abolition des ROT aux MI.

QCM 1 — Les Hypothèses diagnostiques:

- A. Section médullaire complète au niveau D12
- B. Contusion médullaire dorsale
- C. Hématome extradural rachidien compressif
- D. Fracture instable avec compression médullaire
- E. Lésion plexuelle lombaire bilatérale

QCM2 :Examens complémentaires

- A. Scanner du rachis dorsolombaire
- B. IRM médullaire
- C. Radiographie standard en incidence dynamique
- D. Ponction lombaire
- E. Électromyogramme en urgence

QCM3: Le bilan lésionnel a conclu à un traumatisme du rachis dorsal avec fracture corporeale de D12 et recule du mur postérieur avec rétrécissement du canal médullaire de 50 %, La Prise en charge initiale

- A. Immobilisation stricte de l'axe tête-cou-tronc**
- B. Collier cervical rigide systématique**
- C. Corticothérapie IV haute dose systématique**
- D. Réalisation précoce d'une fixation chirurgicale si fracture instable**
- E. Surveillance neurologique rapprochée en réanimation**

CAS CLINIQUE QCM

Un Homme de 25 ans, victime d'un AVP

Il a été éjecté à 10 m de sa voiture pendant le choc

À l'arrivée des secours: le patient n'ouvre pas les yeux à la douleur, ne parle pas et il a un mouvement en retrait des mains au pincement de celles-ci

L'abdomen est souple à la palpation

Le bras droit et la jambe droite sont sièges de volumineux hématomes et le tronc ainsi que le visage comportent de nombreuses plaies

2 côtes adjacentes semblent être tuméfiées en 2 foyers différents

PA =70/45, FC=120/min, SpO2=97%, T°=35,9°C

Quel est le score de Glasgow de ce patient?

- A. 5 (E1-V1- M3)
- B. 6 (E1-V1-M4)
- C. 7 (E2 -V1- M4)
- D. 8 (E2- V1-M5)
- E. 9 (E2- V2- M5)

Un remplissage vasculaire par sérum salé isotonique à 0.9%

Transport à l'hôpital par le SAMU

Sa PA=67/40 (après 1000 cc) , FC=125/min

GAD 5.6 mmol/l, Hb = 6g/dl

Le bilan radiologique de 1ère intention comporte:

- A. Scanner corps entier injecté
- B. Radiographie du thorax de face
- C. Radiographie des membres supérieurs
- D. Échographie abdominale
- E. Radiographie du bassin de face

Lequel (lesquels) de ces dosages sanguins peut(peuvent) être utile (s) à la prise en charge?

- A. Groupe sanguin**
- B. CRP**
- C. Recherches d'agglutinines irrégulières**
- D. Bilan d'hémostase**
- E. Gazométrie artérielle**

Le patient est stabilisé sur le plan hémodynamique. La radiographie thoracique confirme la présence de 2 foyers de fracture sur la 4ème cote droite et 2 foyers de fracture sur la 5ème cote droite sans atteinte des autres côtes. quelles anomalies peut on retrouver sur le body scanner

- A. Pneumothorax**
- B. Volet thoracique**
- C. Hémothorax**
- D. Rupture diaphragmatique**
- E. Lésion splénique**

Cas clinique-QCM2

De garde au SAMU, vous êtes appelé sur les lieux d'un AVP pour PEC d'un polytraumatisé de 19 ans.

À l'examen:

PA=65/30 mmHg, Fc=130/min, SpO2=86%,

T°=37.4

Plaie du scalp de 4x2 cm, dermabrasions au niveau des 4 membres

SG 8/15

Déformation du membre inférieur droit évoquant une fracture tibiale

Quels sont les moyens de la mise en condition immédiate?

- A. Respect de l'axe tête –cou-tronc
- B. Mise en place d'un collier cervical
- C. Pose d'un cathéter veineux central en position fémorale
- D. Intubation orotrachéale pour ventilation mécanique
- E. Sondage urinaire

Quelles mesures thérapeutiques immédiates mettez-vous en œuvre?

- A. Expansion volémique par sérum glucosé 5%
- B. Expansion volémique par sérum salé isotonique
- C. Stabilisation du foyer fracturaire du membre inférieur droit au moyen d'une attelle
- D. Stabilisation du foyer fracturaire du membre inférieur droit au moyen d'un pantalon anti choc
- E. Antibiothérapie intraveineuse à large spectre par imipenème

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre

Stabilisation du rachis cervical et du foyer fracturaire/

IOT + VM avec FiO2 100%/ 2 VVP + remplissage par Ss isotonique

L'hypotension persiste, quel médicament choisissez vous?

- A. Dobutamine
- B. Noradrénaline
- C. Dopamine
- D. Isoprénaline
- E. Amiodarone

Quels examens complémentaires d'imagerie réalisez-vous à l'arrivée à la salle de déchoquage?

- A. Radiographie thoracique**
- B. Radiographie du bassin**
- C. Échographie abdominale**
- D. Échographie pleurale**
- E. Scanner cérébrale**

**Le patient a été stabilisé après sa mise sous catécholamines.
Quelles mesures thérapeutiques mettez vous en œuvre avant
la poursuite des explorations**

- A. Monitoring invasif de la PA après pose d'un cathéter artériel
- B. Mise en place d'un cathéter veineux central sous clavier
- C. Suture de la plaie du scalp
- D. Sérovaccination antitétanique
- E. Pose d'une sonde urinaire

Cas clinique-QCM

Un patient âgé de 25 ans sans antécédent victime d'une chute du troisième étage (environ 10m).

Transporté par la protection civile au service des urgences, l'examen initiale trouve:

FR à 20 cycles/mn, une bonne ampliation thoracique. Les MV sont bien perçus et symétriques. La SpO2 est indétectable

PA 60/30 mm Hg, FC 130 battements/mn, une froideur des extrémités et des conjonctives décolorées

Il n'ouvre pas les yeux à la stimulation douloureuse, localise la douleur et absence de réponse verbale

Un abdomen ballonné, une fracture ouverte de la jambe gauche

Calculer le score de Glasgow :

A. 12/15

B. 9/15

C. 7/15

D. 6/15

E. 3/15

le(s) critère(s) qui gravité immédiate chez ce patient selon Vittel

- A. La présence d'une pression artérielle systolique < 65 mm Hg**
- B. Une fréquence cardiaque à 130**
- C. La chute du troisième étage (environ 10 m)**
- D. La présence d'un abdomen ballonné**
- E. Le coma**

La prise en charge hémodynamique de ce patient doit comporter en urgence :

- A. Un remplissage vasculaires par les cristalloïdes
- B. L'administration de la dobutamine
- C. L'administration de la noradrénaline
- D. La mise en place d'un cathéter sous clavier pour le remplissage
- E. Un monitoring continu de la pression artérielle par un cathéter artériel

Le bilan biologique obligatoire urgent à l'arrivée du patient comporte

- A. Un groupe sanguin**
- B. Une NFS**
- C. Un bilan d'hémostase**
- D. Urée -créatinine**
- E. Un ionogramme sanguin**

Le bilan lésionnel initial (radio thorax , radio bassin et fast echo) a montré la présence d'un hémopéritoine de grande abondance en rapport avec une lacération de la rate, La CAT comporte .

- A. Le bilan lésionnel doit être complété par un body scanner
- B. Le patient doit être admis en réanimation pour stabilisation de son état hémodynamique.
- C. Le patient doit être acheminé immédiatement au bloc opératoire pour parage suture et ostéosynthèse de sa fracture de jambe.
- D. Le patient doit être acheminé immédiatement au bloc opératoire pour une splénectomie d'hémostase
- E. Le patient doit être surveillé en milieu de réanimation et opté pour un traitement non opératoire de la lésion splénique.

Cas clinique-QCM.

Un homme âgé de 43 ans victime d'un AVP suite à un dérapage de sa voiture vers minuit. Il était conducteur, avec ceinture de sécurité, avec décès sur place de sa femme.

L'examen initial par l'équipe de SAMU objective :

*Un patient obnubilé et agité, il se plaint d'une douleur au niveau de l'hypochondre gauche et de la cuisse gauche,

*Il n'avait pas de déficit moteur et ses pupilles étaient en position intermédiaire, symétriques et réactives. Avec notion de PCI

. *PA 75/50 mmHg, le pouls était symétrique et régulier à 140/min et les extrémités froides.

La respiration était superficielle et rapide à 40 cycle /min associé à une abolition du murmure vésiculaire dans tout le champ pulmonaire gauche. La SpO2 est à 80% à l'air ambiant.

Les critères de gravité que présente ce patient selon Vittel

- A. le décès de sa femme**
- B. l'agitation**
- C. Notion de PCI**
- D. la PA 75/50mmHg**
- E. la respiration superficielle et rapide à 40 cycle/min**

la cause la plus probable de la détresse respiratoire chez ce patient.

- A. Une pneumopathie d'inhalation**
- B. Un pneumothorax**
- C. Une embolie pulmonaire**
- D. Un OAP Cardiogénique**
- E. Une dissection de l'aorte**

Les causes les plus probables de la détresse circulatoire chez ce patient.

- A. Un choc obstructif
- B. Un choc cardiogénique
- C. Un choc septique
- D. Un choc vasoplégique
- E. Un choc hémorragique

Ce patient doit bénéficier en urgence sur le lieu du traumatisme de :

- A. Instauration d'une oxygénothérapie**
- B. Une l'exsufflation du pneumothorax à l'aiguille**
- C. Mise en place de d'une voie veineuse centrale**
- D. Un remplissage vasculaire par des cristalloïdes**
- E. Introduction d'emblée de catécholamine**

En plus de la stabilisation des fonctions vitales le patient doit bénéficier de :

- A. Mise en place d'une sonde gastrique**
- B. Réchauffement et lutter contre l'hypothermie**
- C. Une sonde vésicale**
- D. Une analgésie**
- E. Une immobilisation du membre inférieur gauche.**

Ce patient est acheminé au bloc opératoire. Il a à l'échographie abdominale un épanchement intrapéritonéal de grande abondance en rapport avec un fracas de la rate. Son bilan biologique initial objectivé Hb = 6,4 g/dL, leucocytes = 14 500/mm³, plaquettes = 30 000/mm³ ; TP = 28 %, Fg 1,2g/dl

Chez ce patient

- A. L'administration de l'acide tranexamique se fait qu'après la transfusion des CG et des PFC.
- B. Il faut transfuser par des produits sanguins avec un ratio 01 CG / 01 PFC.
- C. Il faut administrer du fibrinogène.
- D. Il faut administrer des culots plaquettaires
- E. L'administration du PPSB est obligatoire